

La pirámide del conocimiento

El conocimiento clínico no aparece de golpe: se construye **capa sobre capa**. Esta pirámide ordena toda nuestra forma de razonar y es la imagen insignia de la Academia.

EN PROFUNDIDAD

Las siete capas

- **1. La persona** — quién es, cómo vive, qué le importa.
- **2. La situación basal** — cómo es cuando está estable.
- **3. La observación** — qué pasa hoy, sin interpretar todavía.
- **4. El microcambio** — qué se apartó de la basal; acá nace la sospecha.
- **5. La interpretación** — qué significa ese cambio.
- **6. La decisión** — esperar, visitar, tratar, derivar o internar.
- **7. El aprendizaje** — qué nos enseñó este paciente para cuidar mejor al próximo.

LA LÓGICA

La secuencia Humana

Toda la organización debería funcionar con una misma lógica: **observar** → **comprender** → **decidir** → **actuar** → **medir** → **aprender**. Después el ciclo vuelve a empezar, y cada vuelta hace que conozcamos mejor al paciente y que el sistema aprenda.

Toda observación debe cambiar el cuidado. Cada dato debe responder: «¿qué vamos a hacer distinto gracias a esta información?».

EN LA PRÁCTICA

Ubicá tu caso

Tomá un paciente real y ubicá dónde estás parado en la pirámide. La mayoría de los errores nace de saltar capas: interpretar sin describir, o decidir sin comprender.

LA IDEA PARA LLEVARTE

Formar deja de ser memorizar enfermedades y pasa a ser aprender cómo se construye el conocimiento. Y la continuidad no depende de que atienda siempre el mismo médico: depende de que el conocimiento del paciente no se pierda nunca.